



S. BOUAM (1), A. BENOuada (1)
(1) EPH Arris-1, Batna, Algérie

Introduction

L'hyperuricémie est l'un des marqueurs biologiques les plus précoces de la pré-éclampsie, précédant souvent de plusieurs semaines l'hypertension artérielle (HTA) et la protéinurie pathologique.

Ce cas illustre comment une élévation massive de l'acide urique permet d'identifier un risque majeur de complication vasculaire gravidique chez une patiente initialement asymptomatique sur le plan tensionnel.

Message clé

Une hyperuricémie sévère, même sans HTA ni protéinurie franche, doit faire évoquer une pré-éclampsie débutante au 3ème trimestre.

Objectif

Souligner, à travers un cas clinique, la valeur d'alerte de l'acide urique lorsque la collection des urines de 24 heures est irréalisable et que les signes cliniques cardinaux de la pré-éclampsie sont encore absents.

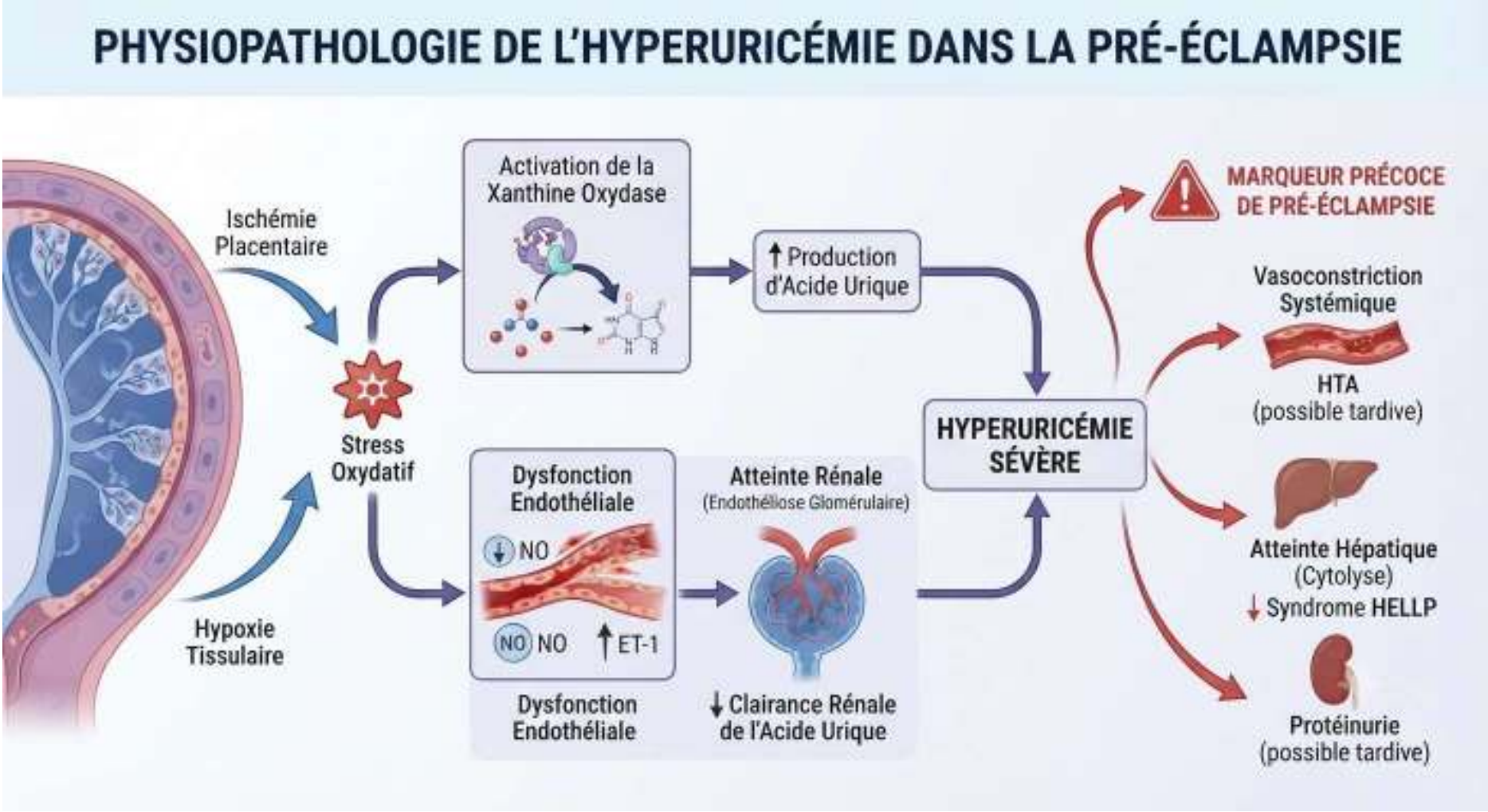
Physiopathologie

Hypoxie placentaire : Le défaut d'invasion trophoblastique au 1er trimestre engendre un stress oxydatif ischémique majeur.

Surproduction de l'urate : Activation accrue de la xanthine oxydase et apoptose placentaire libérant l'acide urique dans la circulation.

Dysfonction endothéliale : L'isoxie induit une vasoconstriction généralisée et une endothéliose glomérulaire, réduisant la clairance rénale de l'urate.

Boucle délétère : L'hyperuricémie amplifie elle-même le stress oxydatif endothélial, aggravant la sévérité de la pré-éclampsie.



Observation Clinique

Patiente de 40 ans, primipare, 32 SA

Admise pour vomissements incoercibles et asthénie. Examen initial : absence d'HTA et de signes neurologiques.

Bilan biologique à l'admission

Paramètre	Valeur	Valeurs usuelles	Interprétation
Acide urique (mg/L)	152,84	35 – 60 (T3)	Hyperuricémie majeure
Protéines urinaires (BU)	1+	Négatif	Protéinurie non significative
Kaliémie (mmol/L)	2,4	3,5 – 5,0	Hypokaliémie profonde
Calcémie (mg/L)	112,36	88 – 102	Hypercalcémie iatrogène
ALAT (UI/L)	172,80	< 41	Cytolyse hépatique
ASAT (UI/L)	159,15	< 40	Cytolyse hépatique
Lipasémie	Normale	Normale	—
FNS	Normale	Normale	—

Collection des urines de 24 h non réalisable (état clinique de la patiente).



Signal d'alarme

Hyperuricémie majeure isolée, sans HTA ni protéinurie franche : tableau évocateur d'une pré-éclampsie infra-clinique.

Conclusion diagnostique : Profil biologique évocateur d'une pré-éclampsie débutante avec atteinte hépatique, associée à des désordres hydro-électrolytiques d'origine mixte (digestive et iatrogène).

Particularité du cas

L'absence d'HTA et la présentation digestive trompeuse (vomissements incoercibles) auraient pu retarder le diagnostic en l'absence du dosage de l'acide urique, révélateur d'un risque vasculaire gravidique majeur.

Discussion

L'hyperuricémie sévère au 3ème trimestre constitue un véritable « système d'alarme » biologique. En situation d'urgence, lorsque la collection des urines de 24 heures est irréalisable et en l'absence d'HTA, l'acide urique s'impose comme le pivot décisionnel.

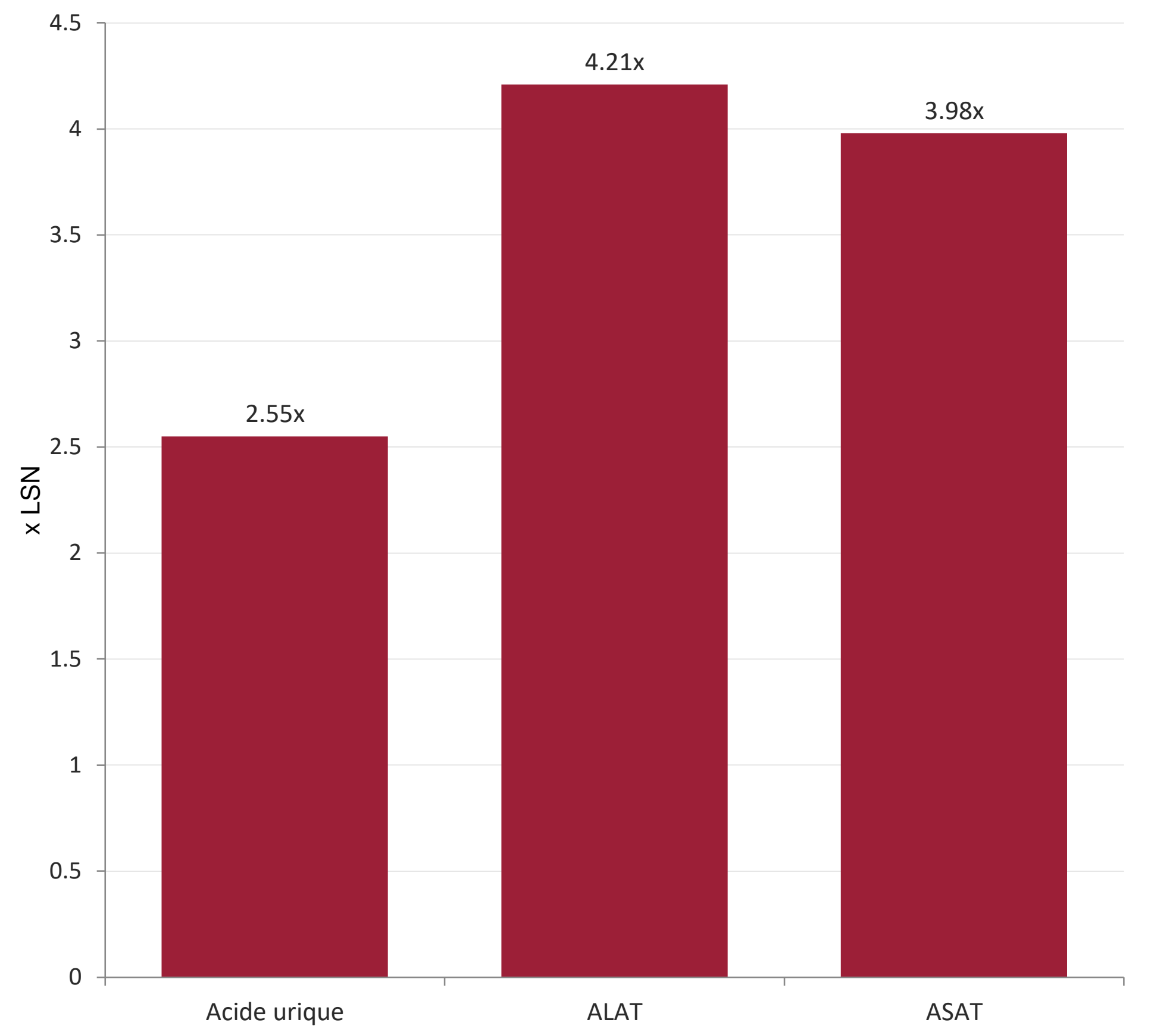
Sur le plan physiopathologique, l'hyperuricémie résulte d'une production accrue par la xanthine oxydase placentaire (hypoxie) et d'une clairance rénale réduite (dysfonction endothéliale glomérulaire). L'acide urique et les cristaux d'urate de sodium activeraient aussi l'inflammasome NLRP3, amplifiant l'inflammation placentaire et vasculaire de la pré-éclampsie [1].

Une méta-analyse (n > 39 000) retrouve, au 3ème trimestre, une sensibilité de 76,7 % et une spécificité de 79,6 % de l'hyperuricémie pour le diagnostic de pré-éclampsie, avec des taux d'acide urique plus élevés en cas de forme sévère, d'éclampsie ou de syndrome HELLP [2]. Une large étude cas-témoins confirme une association dose-dépendante avec le risque de pré-éclampsie (OR ajusté = 1,21/DS) [3], l'hyperuricémie tardive étant aussi liée à un risque accru de césarienne et de petit poids de naissance [4].

Le Piège Clinique des Formes Trompeuses

Comme l'illustre notre observation, l'hyperuricémie peut rester isolée, sans HTA ni protéinurie franche, sous un tableau digestif trompeur (vomissements, hypokaliémie) imposant sa recherche systématique au 3ème trimestre.

Élévation vs limite supérieure de la normale



LSN = limite supérieure de la normale. Les trois marqueurs sont franchement élevés dès l'admission, avant tout signe tensionnel.

Implication pratique

Une hospitalisation immédiate en soins intensifs obstétricaux, une correction ionique et une surveillance fœto-maternelle stricte sont impératives devant ce tableau, évocateur d'un risque de pré-éclampsie sévère ou de syndrome HELLP.



Conclusion

Ce cas démontre que l'hyperuricémie sévère au 3ème trimestre constitue un véritable système d'alarme biologique. Sa valeur prédictive permet de suspecter une pathologie vasculaire grave (pré-éclampsie, syndrome HELLP) là où les seuls signes cliniques (vomissements) auraient pu égarer le diagnostic vers une affection digestive. Une hospitalisation immédiate en soins intensifs obstétricaux, une correction ionique et une surveillance fœto-maternelle stricte sont impératives.